

间质性膀胱炎 / 膀胱疼痛综合征 (IC/BPS)

患者须知 · 非感染性慢性膀胱疼痛与尿急

WARWIKI

间质性膀胱炎，又称膀胱疼痛综合征 (IC/BPS)，是一种以膀胱或盆腔疼痛、压迫感或不适为主要表现的慢性疾病，同时伴有频繁或紧迫的排尿需求——并非由感染引起。不适感通常随膀胱充盈而加重，排尿后缓解。虽然没有一步到位的治疗方法，但症状是可以得到良好控制的。

关于这种疾病

IC/BPS 不是感染，也不会传染。症状因人而异，往往出现**发作**（症状加重期）与缓解交替的规律。常见表现：

- 膀胱或盆腔疼痛、压迫感或不适
- 日夜频繁排尿和（或）尿急
- 不适感随**膀胱充盈而加重**，排尿后减轻
- 某些食物、压力或月经周期可诱发发作

病因

确切病因尚不清楚，可能涉及膀胱内壁敏感或受刺激、神经过度敏感，以及（常见的）**盆底肌紧张过度活跃**的综合作用。由于致病因素较多，治疗通常需要多种方法联合使用。

名词解释

IC/BPS

间质性膀胱炎 / 膀胱疼痛综合征——膀胱疼痛伴尿急，非感染所致。

发作

症状加重期，常由食物或压力诱发。

排除性诊断

排除感染等其他病因后方可诊断。

盆底物理治疗

通过物理治疗松解紧张的盆底肌。

膀胱灌注

通过细导尿管将舒缓药物注入膀胱。

Hunner 病变

部分患者膀胱壁上可见的特定病灶，可直接治疗。

膀胱镜检查

用细镜头直视膀胱内部。

会好转吗？ IC/BPS 通常是慢性病，但大多数人通过联合治疗并了解自身诱发因素后能获得明显缓解。目标是减少发作次数、减轻发作程度，恢复正常生活——找到适合自己的方案需要一些尝试，请对这个过程保持耐心。

如何诊断

没有单一的诊断检查。医疗团队在排除其他病因后，根据症状作出诊断：

- **尿液检查**，排除感染或血尿
- 症状病史和**排尿日记**
- 有时需要**膀胱镜检查**，查找 Hunner 病变

如何治疗（逐步进行）

- 1 **自我管理**——了解**食物诱因**，管理压力和睡眠，进行温和的膀胱训练。
- 2 **盆底物理治疗**——松解紧张肌肉（注意：强力凯格尔运动可能加重症状）。
- 3 **药物治疗**——口服药物及舒缓性**膀胱灌注**。
- 4 **靶向及进阶治疗**——针对 Hunner 病变的治疗，或难治性病例的神经刺激疗法。

日常管理

- 常见诱因包括**咖啡、茶、酒精、柑橘类水果、番茄和辛辣食物**——可逐一排除再逐一恢复，找出属于自己的诱因。
- 制定**发作应对方案**（休息、热敷、多饮水、清淡饮食）。
- 压力和盆底肌紧张会形成恶性循环——温和运动和放松训练有助于改善。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热、寒战或腰背 / 侧腹疼痛（可能为感染）
- 新出现的**血尿**
- 无法控制的发作，或无法排尿

需要记住的三件事

1. IC/BPS 是伴有尿急的膀胱 / 盆腔疼痛，**不是**感染——属慢性病，但完全可以控制。
2. 治疗需综合自我管理与诱因控制、盆底物理治疗、药物及灌注治疗，以及针对特定病灶的**靶向治疗**。
3. 了解您的食物和压力诱因，制定发作应对方案。新出现的血尿、发热或侧腹疼痛应及时就诊。